



NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 4 SEMESTRE 2026A		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE : SAMUEL PALACIO PEÑA		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: UROLOGIA	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:

PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR:
PROSTATECTOMÍA ABIERTA TRANSVESICAL

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA

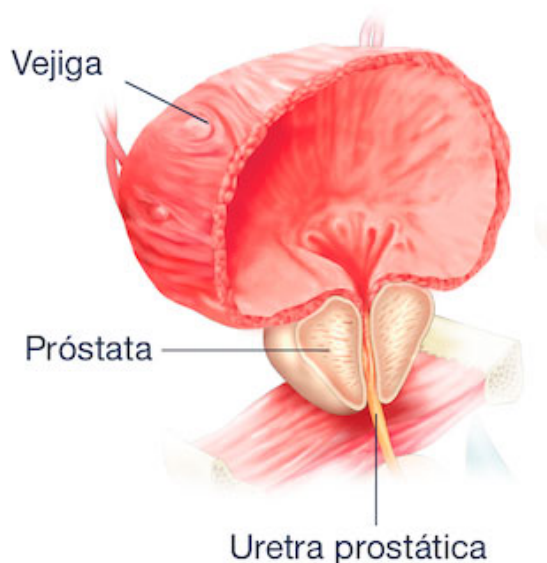
1. ETAPA DE PLANEACIÓN:

1.1. Objetivo Quirúrgico: (Hacer descripción)

Extirpar de forma completa el adenoma prostático de gran volumen a través de un abordaje transversal abierto para eliminar la obstrucción del tracto urinario inferior.

1.2. Anatomía y fisiología: (Hacer gráfico y descripción).

ANATOMIA

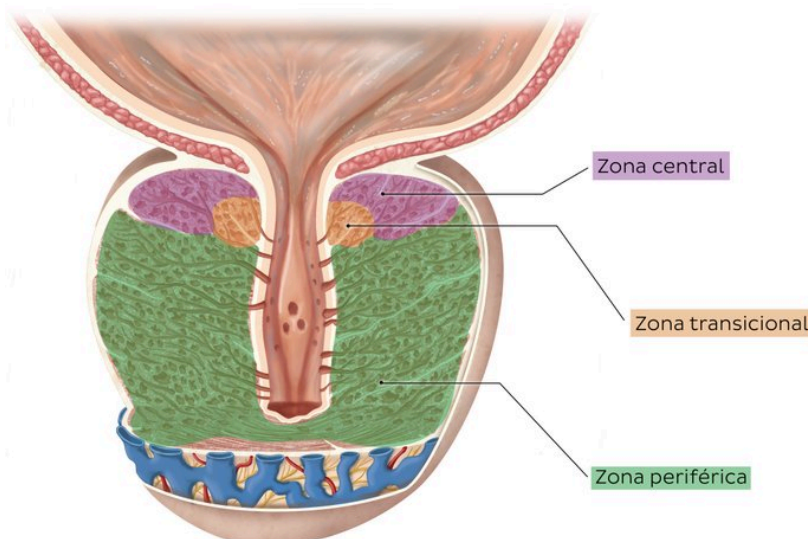


Es una glándula accesoria del sistema reproductor masculino. Es del tamaño de una nuez, y se localiza alrededor de la

porción prostática de la uretra (uretra prostática). Anatómicamente, la próstata está compuesta por un istmo, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo.

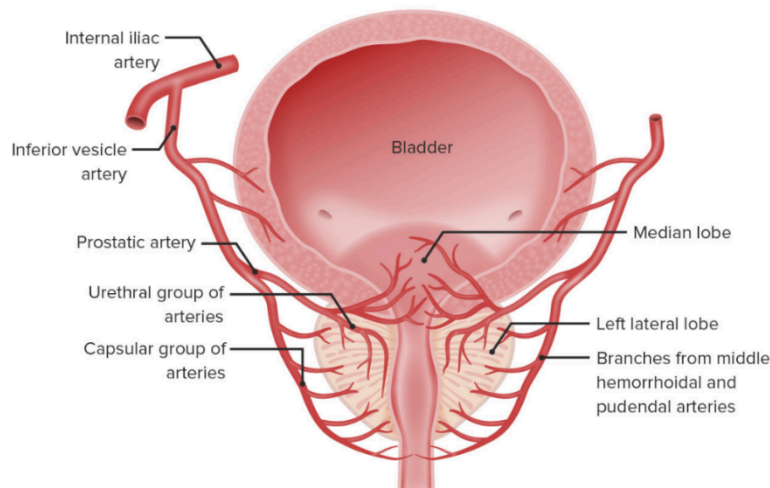
1. **ISTMO:** Se encuentra anterior a la uretra. Está compuesto principalmente por tejido fibroso y muscular, con poco o nulo tejido glandular.
2. **LÓBULO IZQUIERDO Y DERECHO:** Están separados anteriormente por el istmo, y posteriormente por un surco longitudinal que se extiende sobre la línea media de la cara posterior de la próstata. Cada lóbulo está dividido en cuatro lobulillos, con base en sus relaciones anatómicas con el conducto eyaculador y la uretra prostática, que son los siguientes:
 - Lobulillo inferoposterior: inferior a la uretra y posterior al conducto eyaculador.
 - Lobulillo inferolateral: posicionado lateralmente a la uretra.
 - Lobulillo superomedial: por debajo del lobulillo inferoposterior y alrededor del conducto eyaculador.
 - Lobulillo anteromedial: inferior al lobulillo inferolateral y lateral a la porción proximal de la uretra prostática.

La próstata consta a su vez de una base, vértice, cara anterior, cara posterior y unas caras inferolaterales. Y a su vez se divide en zonas: una zona central, una zona periférica, zona transicional y estroma fibromuscular anterior



1. **Zona central:** se encuentra en la base de la próstata, envolviendo los conductos eyaculadores y se conforma por las glándulas submucosas periuretrales
2. **Zona transicional:** es corta y rodea la porción proximal de la uretra prostática superior al colículo seminal, está formada por las glándulas mucosas periuretrales.
3. **Zona periférica:** Se compone por las glándulas prostáticas principales

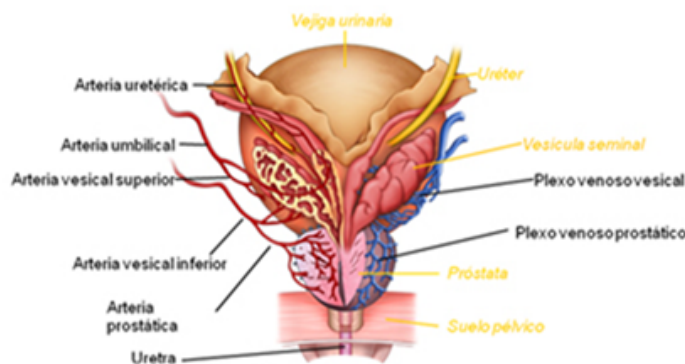
VASCULARIZACION



La fuente principal de irrigación arterial de la próstata es:

- Arteria pudenda interna, con algunas contribuciones adicionales de las arterias vesical inferior y rectal media

DRENAJE VENOSO



El drenaje venoso se realiza a través del plexo venoso prostático, que conduce la sangre hacia las venas ilíacas internas.

INERVACIÓN

Esta inervada por las fibras parasimpáticas de los nervios esplácnicos pélvicos del plexo prostático, que reciben sus fibras del plexo hipogástrico inferior (para erección y efecto secretomotor de acinos), el plexo hipogástrico inferior a su vez recibe fibras simpáticas preganglionares del plexo hipogástrico superior para brindar inervación motora a los músculos lisos del estroma glandular (para eyaculación y contracción muscular lisa).

FISIOLOGÍA



Su función es la de producir el fluido prostático, que, en combinación con el esperma proveniente de los testículos, componen el semen y a su vez la función principal del fluido prostático es activar a las células espermáticas, por lo que asiste en el proceso general de la reproducción.

1.3. Lista de chequeo

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FARMACOS Y SOLUCIONES
Canasta general	Paquete de ropa	PIEL:	Solución Salina
Canasta de urología	Dren de Jackson-Pratt	Polipropileno 2/0 Aguja curva cortante 3/8 de círculo	Lidocaina jalea
Separador de Judd-Mason	Pala larga del electrobisturí	TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO:	Surgicel
Pinza Heany	Aseptojeringa	Poliglactina 910 2/0 Aguja curva redonda ½ de círculo	
Rochester Pean	Cánula de Yankauer	FASCIA: Poliglactina 910 0 -1 Aguja curva redonda ½ de círculo	
Valva suprapúbica	Electrobisturí	LECHO PROSTÁTICO:	
	Consola del electro	Poliglactina 910 0- 2/0 Aguja curva redonda 1/2 de círculo	
	Caucho de succión	seda 2/0 precortada	
	Hoja de bisturí #15 - #20		
	Mango de bisturí 3 y 4		
	Jeringa de 10cc		
	Cystoflo		
	Guantes		
	Frasco de patología		
	Equipo de venoclisis		
	Compresas y apósitos		
	Sonda Foley de 3 vías 22-24		

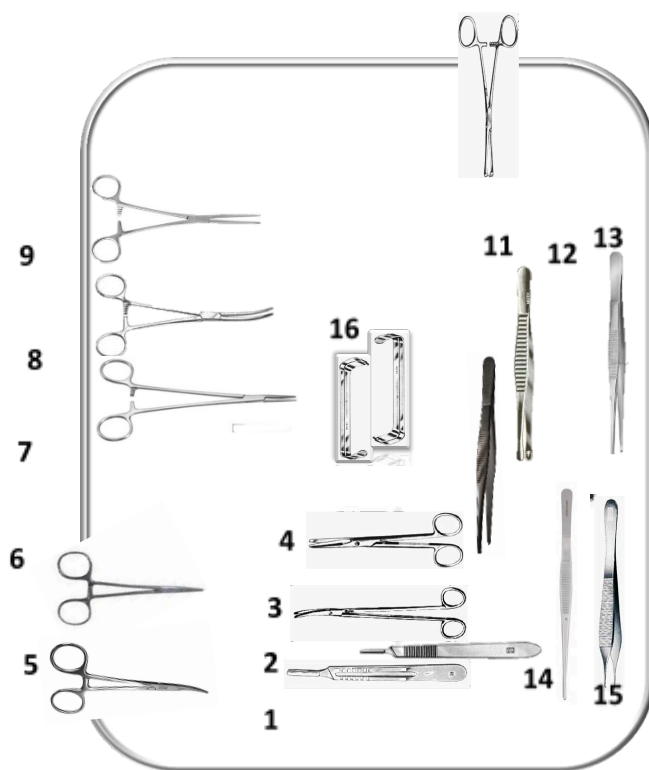


Equipo de irrigación en
Y

2. ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

- a. Arreglos de mesas de mayo y reserva (realizar esquema).

MESA DE MAYO



- Mango de bisturí 3
- Mango de bisturí 4
- Tijera de Metzembraum
- Tijera de Mayo
- Pinza Kelly curva
- Pinza Kelly recta
- Pinza Kelly Adson
- Pinza Rochester curva
- Pinza Rochester recta
- Pinza Allix
- Pinza de disección Rusa o Rusell
- Pinza de disección sin garra
- Pinza de disección con garra larga
- Pinza de disección sin garra larga
- Pinza de disección Adson con garra
- Separadores de Farabeuf
- Pinza Heany
- Pinza Rochester Pean



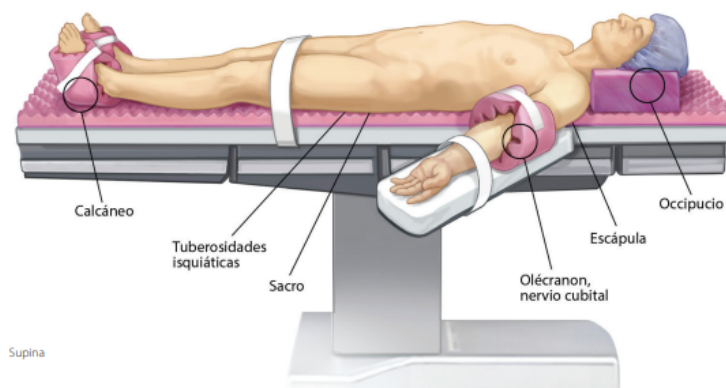
MESA DE RESERVA



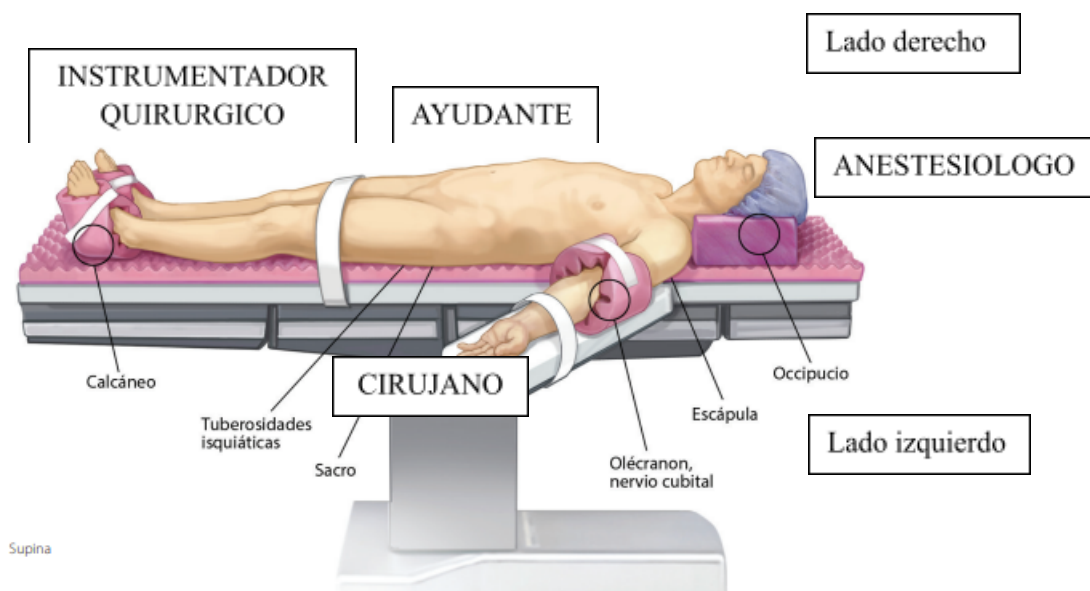
1.Canasta general 2.Canasta de urología 3.Aseptojeringa 4.Valva maleable 5.Separadores de Deaver 6.Pinza Foester 7.Cánula de Yankawer 8.Cistoflo 9.Sonda Nelaton 10.Equipo de Venoclis 11.Sonda Foley 22x30 tres vias 12.Sonda Foley 22x30 dos vias 13.Guantes 14. Caucho de succión 15.Lapicero del electrobisturí 16.Paquete de ropa 17.Portaagujas 18.Compresa y suturas 19.Pinza de campo 20.Coca 21.Separador de judd-masson 22.Valva suprapúbica 23.Surgicel 24.

2.2. Posición del paciente (Nombre y gráfico):

Posición Decúbito supino



2.3. Ubicación del Equipo Quirúrgico (realizar gráfico):



3. ETAPA DE EJECUCION:

- Anestesia (escribir el tipo de anestesia):** Anestesia Raquídea
- Incisión (escribir el tipo de abordaje y el nombre de la incisión):** Incisión mediana infraumbilical
- Proceso Quirúrgico (Describir los pasos principales de la técnica médico quirúrgica con el instrumental a usar).**

TECNICA QUIRURGICA	INSTRUMENTAL
Incisión mediana infraumbilical	Mango de bisturí 4 Hoja de bisturí 20
Hemostasia	Pinza Kelly curva Lapicero del electrobisturí
Visualización, incisión de la fascia, músculos rectos y divulsión de estos	Pinza Kelly curva Lapicero del electrobisturí
Visualización de la vejiga	
Reparos a los lados de la vejiga	Seda 2/0 o 3/0 aguja ½ círculo redonda



Tracción de la vejiga e incisión	Pinza Allix Mango de bisturí 4 largo Hoja de bisturí 15
Aspiración de la vejiga	Cánula de Yankauer
Visualización del cuello vesical	Separador de Deaver ancho
Sección y resección de la mucosa prostática y glándula	Electrobisturí con pala larga
Circuncidados de la próstata y extracción	Tijeras de Metzembbaum
Sutura del lecho prostático	Portaagujas largo Dissección sin garra Poliglactin 910 0- 2/0 aguja ½ redonda
Colocación de la sonda en el cuello vesical	Sonda Foley 22x30 tres vías Jeringa de 10 cc Cystoflo Equipo de venoclisis Solución salina de 100 cc
Dren por contrabertura	Cystoflo
Sonda para cistostomía	Sonda Foley 22x30 tres vías Jeringa 10 cc Cystoflo
Cierre por planos y curación	Portaagujas mediano Pinza de dissección con garra Separador de Farabeuf Pinza de dissección Adson con garra Poliglactin 910 2/0 aguja medio circulo redonda Polipropileno 3/0 aguja curva cortante



**Universidad
de Santander**
Personería Jur. 810 de 12/03/96 Min.Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN **UDES**

PROGRAMA DE INSTRUMENTACION QUIRURGICA

**PLANEAMIENTO QUIRURGICO PRACTICA
FORMATIVA
IQX-FT-003-BUC**

Versión: 01